

SOMMAIRE

- I. Les différentes formes de jeûne**
 - 1. Introduction au jeune
 - 2. Le jeune hydrique
 - 3. Le jeune sec
 - 4. Le jeune Buchinger
- II. La physiologie du jeûne**
 - 1. Phase 1 Utilisation des réserves de glucose
 - 2. Phase 2 Néoglucogenèse hépatique
 - 3. Phase 3 La cétogenèse
 - 4. Durée du jeûne
- III. Les effets du jeûne sur l'organisme**
 - 1. Adaptation du métabolisme
 - 2. L'autophagie
 - 3. La crise d'acidose
- IV. Les bénéfices du jeûne**
- V. Les contre-indications au jeûne**
- VI. La pratique du jeûne**
 - 1. Se préparer à jeûner
 - 2. La descente alimentaire
 - 3. L'entrée dans le jeûne: la purge
 - 4. Optimiser son jeûne
- VII. Après le jeûne**
 - 1. La reprise alimentaire
 - 2. Et après le jeûne

I. LES DIFFERENTES FORMES DE JEUNE

1. INTRODUCTION AU JEUNE

❖ Le jeûne, une pratique naturelle

- **Toute la nature jeûne depuis toujours**
 - ⇒ Les végétaux constituent des réserves dans les tubercules
 - ⇒ Les animaux stockent des réserves avant d'entrer en hibernation
- **Et chez nous les humains**
 - ⇒ Dans l'histoire de l'humanité, nos ancêtres lointains ont traversé des périodes de privation de nourriture.
 - ⇒ La pratique du jeûne s'imposait par l'approvisionnement aléatoire en nourriture et par des conditions climatiques extrêmes
 - ⇒ Le jeûne fait partie pratiquement de toutes les religions du monde

- Christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, hindouisme

❖ Le jeûne thérapeutique médical

➤ Des cliniques médicales proposent des séjours de jeûne de durée variables sous supervision médicale

⇒ **En Russie** le centre de Goryachinsk sur les bords du lac Baïkal a accueilli plus de 30 000 personnes en 50 ans qui ont suivi des jeûnes thérapeutiques pour des maladies telles que diabète de type 2, asthme, hypertension, rhumatismes, allergie.

- Les cas cliniques ont été consignés au fil des ans mais non traduits

⇒ **En Allemagne**, les cliniques Buchinger, sur les rives du lac Constantin proposent des cures de 2 à 3 semaines supervisées médicalement

- Le jeûne est enseigné dans certains hôpitaux universitaires
- Il est remboursé par l'assurance maladie (système public allemand) dans certains centres

⇒ **En France**, le jeûne thérapeutique médical n'est pas reconnu

➔ Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman, Le Jeûne, une nouvelle thérapie



❖ Jeûner, c'est :

- Une abstinence de nourriture sur une période donnée, Selon Herbert Shelton

- Mettre le corps au repos

⇒ Sans plus d'effort digestif, ni mécanique, ni sécrétoire, ni nerveux,

- Économiser une quantité insoupçonnée d'énergie

⇒ Un repas «normal» élève la dépense basale de 30 %, soit près de 300 calories

- Uniquement par la mise en fonction des organes mécaniques et sécrétoires digestifs

⇒ L'organisme va dériver cette énergie

- Vers les émonctoires, nos organes de détoxination et d'élimination

- le foie, les reins, les poumons, les intestins, la peau

- Vers les réfections tissulaires (réparation, régénération)

➔ Alain Huot, Le Jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit, Eds Dangles

2. LE JEUNE HYDRIQUE

➤ Jeûne qualifié de strict ou puriste

- ⇒ Autorise uniquement l'eau plate, l'eau pétillante
 - 1,5 à 3 litres par jour
- ⇒ Additionnée de sel
 - ½ à ¾ cuillère à café dans 1 litre d'eau
- ⇒ Dr Evelyne Bourdua-Roy ne le conseille pas plus de 5 jours consécutifs
 - pour les jeûneurs novices
 - Pour les personnes qui ont des problèmes de santé
- ⇒ Supplément en magnésium conseillé

➔ Dr Evelyne Bourdua-Roy et Sophie Rolland, Comment jeûner

3. LE JEUNE SEC

• Jeûne sans aucun liquide, ni aliment

- ⇒ Pas de tisanes, ni bouillons,
- ⇒ Pas de douche, ni lavage de dents

• Démarche personnelle

- ⇒ Aucun centre n'encadre ce type de jeûne

• A conduire sur une période très courte

- ⇒ 12h (Ramadan) (max 72 heures)
- ⇒ Pourrait être dangereux pour les reins

- ⇒ S'y engager avec une très grande prudence
- ⇒ En prolongation d'un jeûne hydrique

➔ Dr Evelyne Bourdua-Roy et Sophie Rolland, Comment jeûner

4. LE JEUNE BUCHINGER

- **Pratique mise au point par le Dr Otto Buchinger au siècle dernier en Allemagne**
 - ⇒ A consacré sa vie à étudier le jeûne et l'utiliser comme thérapie auprès de ses patients
- **Apport calorique de 250 kcal par jour,**
 - ⇒ ¼ litre de jus de fruits fraîchement pressés servi le matin
 - ⇒ ¼ litre de bouillons de légumes servi le soir
 - ⇒ eau minérale
 - ⇒ tisanes

=> Permet une entrée en douceur dans le processus du jeûne

- **Période de jeûne prolongé**
 - ⇒ 10 à 21 jours dans les cliniques Buchinger
 - ⇒ 4 jours de remontée alimentaire inclus dans le séjour de jeûne

→ Dr Françoise Wilhemi de Toledo, L'art de jeûner, Eds Jouvence

II. LA PHYSIOLOGIE DU JEUNE

1. PHASE 1 UTILISATION DES RESERVES DE GLUCOSE

❖ Utilisation des réserves de glucose

- **Réserves immédiatement disponibles et mobilisables**
- **Glucose disponible circulant dans le sang**
- **Au bout de 3-4 heures le glycogène est libéré via la glycogénolyse**

⇒ Le foie libère le glucose stocké sous forme de glycogène

⇒ Seuls le foie et les muscles sont capables de stocker du glycogène

▪ Les muscles pour leurs propres besoins

énergétiques

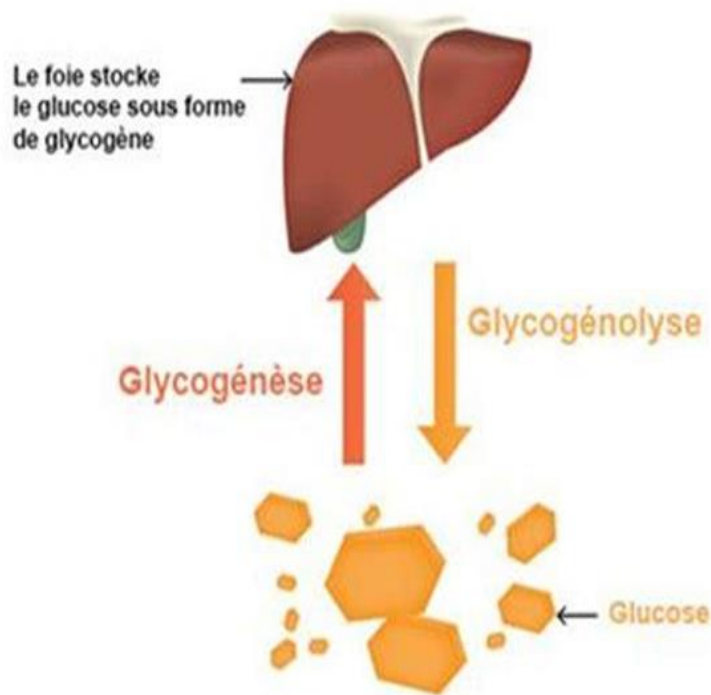
▪ Le foie pour le métabolisme

⇒ Commandée par la baisse de l'insuline et l'élévation du glucagon

❖ Glycogénèse / Glycogénolyse

- **Les réserves hépatiques de glycogène sont de**
- **100 à 125 gr chez l'homme adulte**
 - ⇒ Besoins énergétiques évalués à 5g de glycogène par heure
 - ⇒ **Autonomie de 20 heures**

Glycogénèse / Glycogénolyse



2. PHASE 2 NEOGLUCOGENESE HEPATIQUE

❖ La néoglucogénèse

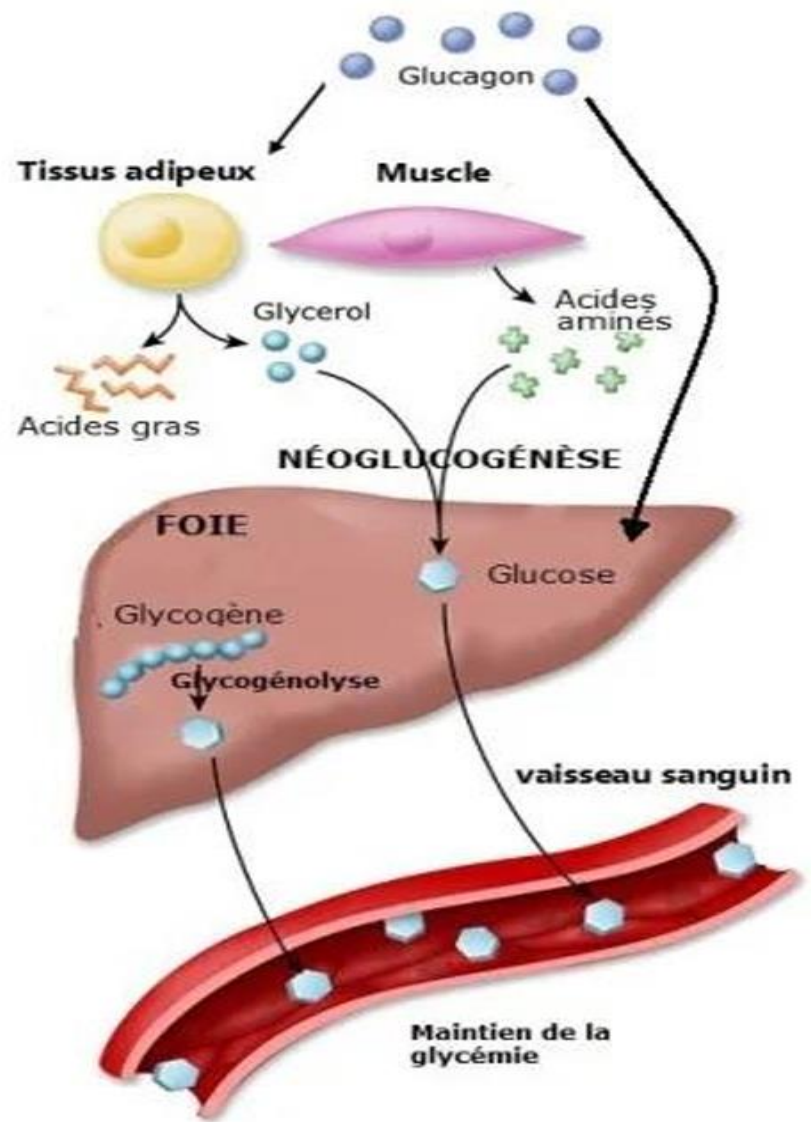
- Le glycogène est épuisé
- Le foie commence à produire du glucose avec d'autres substrats non glucidiques, via la néoglucogénèse (fabrication de nouveau glucose)
 - ⇒ Création de glucose à partir
 - des protéines: **protéolyse**
 - des lipides: **lipolyse**
 - ⇒ Pour fournir les cellules dépendantes au glucose
- Processus métabolique coûteux
- Pour produire une molécule de glucose, le foie doit brûler 4 de ses propres ATP

❖ Protéolyse

- Fragmentation d'une protéine en acides aminés
- Certains AA peuvent être convertis en glucose, d'autres en corps cétoniques
- Permettent de répondre aux **besoins énergétiques du cerveau**
 - ⇒ **120 gr par jour**
- La protéolyse est majoritaire dans cette étape intermédiaire
 - ⇒ Provoque une fonte protéique : **200gr par jour**

❖ Lypolyse

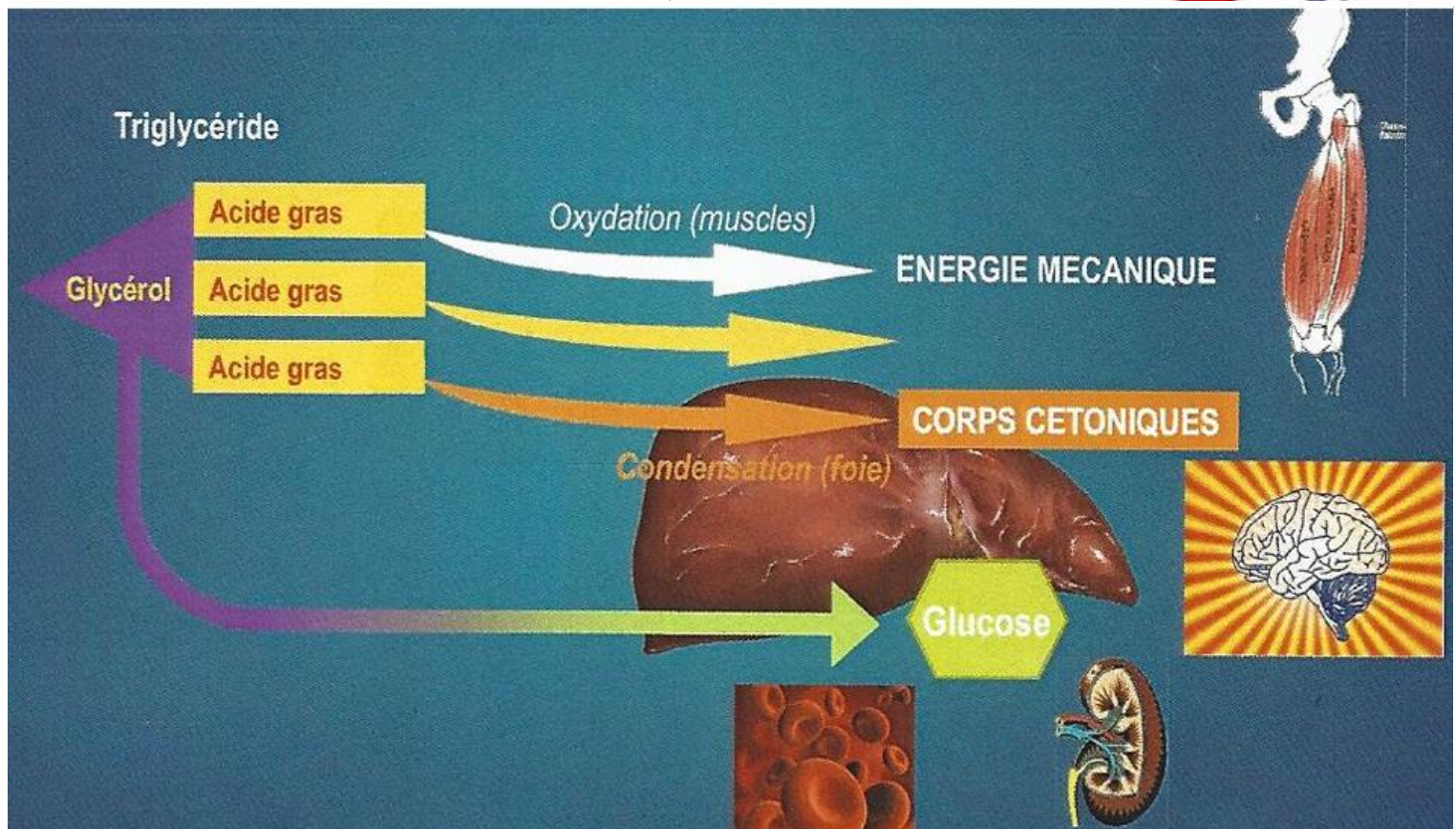
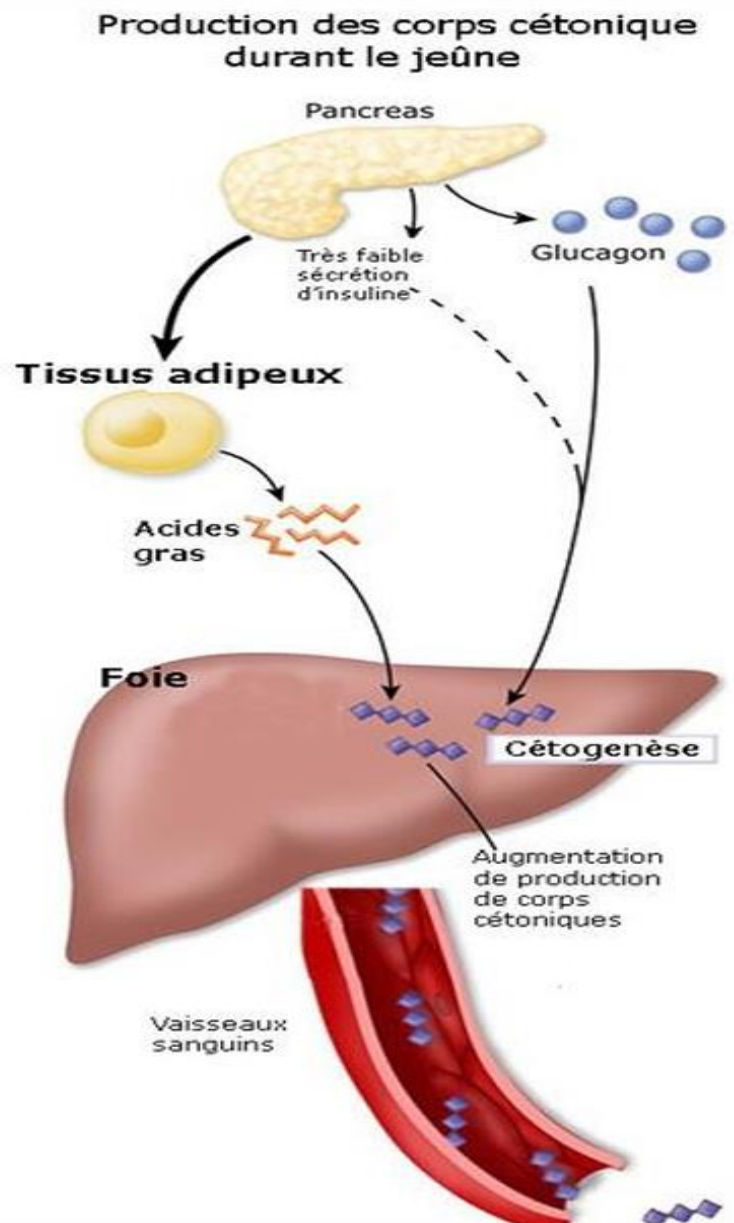
- Sous l'action conjointe du glucagon et de l'adrénaline, les triglycérides stockés dans nos adipocytes sont déstockés
 - ⇒ Le glycérol est converti en glucose pour les cellules gluco-dépendante
 - Neurones, globules rouges,
 - ⇒ Les acides gras sont convertis en corps cétoniques
 - Tous les tissus peuvent les utiliser comme **substrats énergétiques**, y compris le cerveau
 - Mécanisme naturel mais inhabituel: **bascule métabolique**



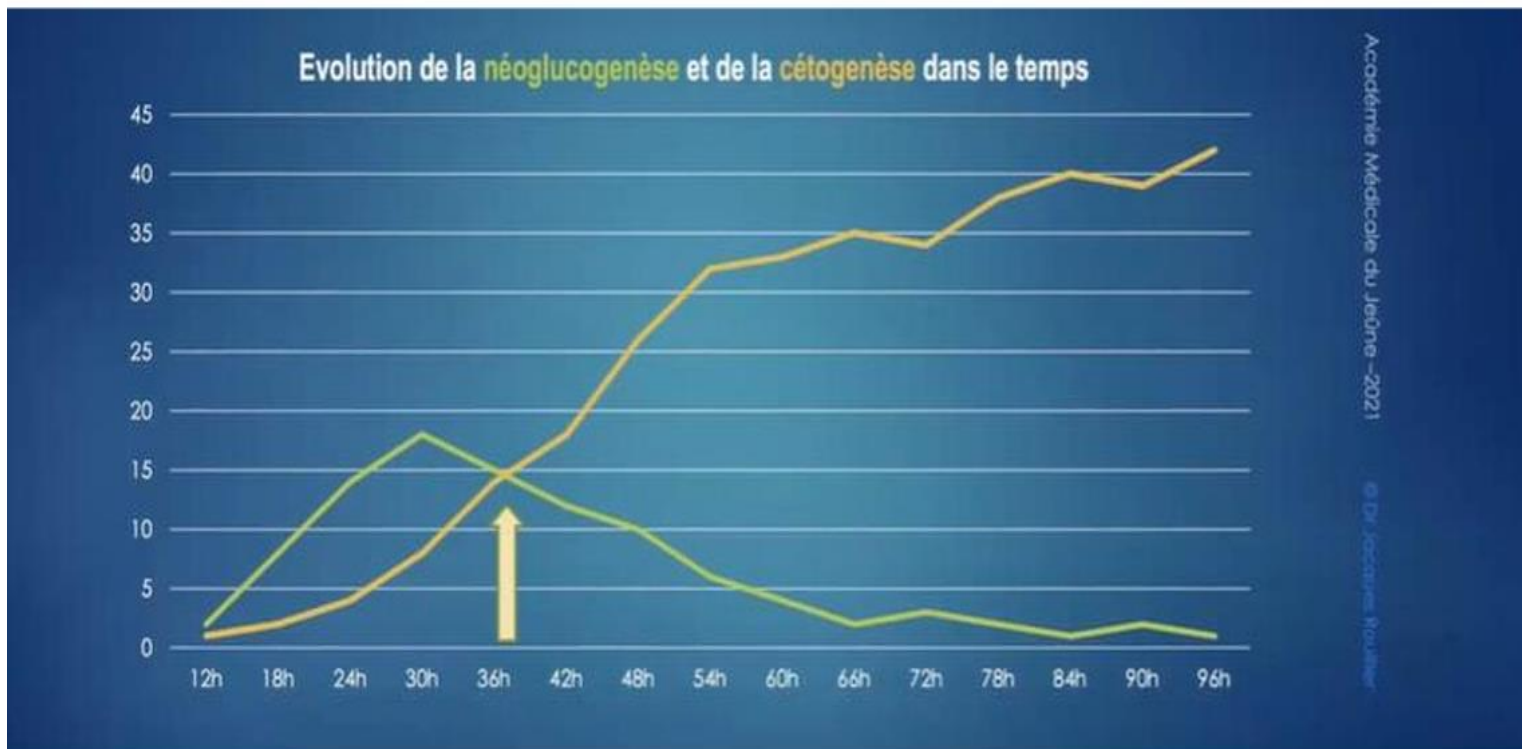
3. PHASE 3 LA CETOGENESE

❖ Cétogénèse

- A partir du jour 3-4 la lipolyse est à plein régime
 - Le corps va privilégier la consommation des triglycérides du tissu adipeux
 - ⇒ Une partie des lipides est transformée en corps cétoniques utilisables par les cellules du cerveau
 - Le cerveau ne peut pas utiliser les acides gras
 - Les besoins totaux en glucose passent progressivement de 140gr à 40gr par 24h
 - L'apport des protéines diminue progressivement
 - ⇒ Plancher 4% par jour
 - ⇒ Préserve les muscles et le cœur
- Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman, Le Jeûne, une nouvelle thérapie



❖ Evolution de la néoglucogenèse et de la cétogenèse dans le temps



❖ Pertes en eau, graisses, protéines pendant le jeûne

Les pertes en eau sont sensibles surtout dans les premiers jours, et diminuent rapidement

Les pertes en protéines sont transitoires

Les pertes en **graisses** se poursuivent régulièrement

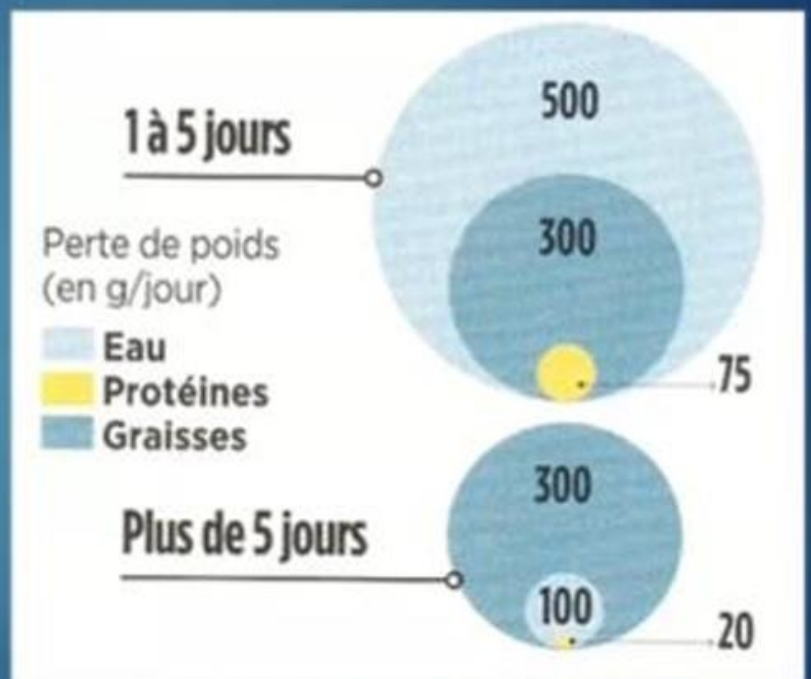


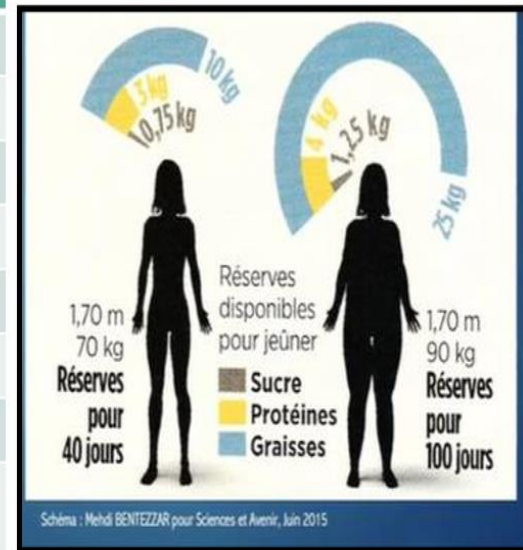
Schéma : Mehdi BENTEZZAR pour Sciences et Avenir, juin 2015

3. DUREE DU JEUNE

❖ Tant qu'il y a de la graisse à brûler

- Dr George F. Cahill (1927-2012), spécialiste du métabolisme du glucose et des graisses

Personne 1,70m pesant 70 kg	Personne 1,70m pesant 90 kg
<u>Réserves de graisses mobilisables</u>	<u>Réserves de graisses mobilisables</u>
10 kg / 90 000 calories	25 kg / 225 000 calories
<u>Réserves de protéines mobilisables</u>	<u>Réserves de protéines mobilisables</u>
3 kg / 12 000 calories	4kg / 16 000 calories
<u>Consommation journalière</u>	<u>Consommation journalière</u>
2500 calories	2500 calories
Peut jeûner 40 jours	Peut jeûner 100 jours
Jeûne avec oxygénation et mouvements physiques Les tissus vitaux sont conservés	



Science et Avenir juin 2015

❖ Record du jeûne

1965 un jeune écossais de 27 ans 207 kg

- ⇒ Démarre son jeûne à l'hôpital avec contrôle de ses paramètres sanguins, d'élimination
 - acide urique, urée, créatinine, tension,...
- ⇒ Puis continue chez lui avec un contrôle médical régulier
- ⇒ Prend ponctuellement des vitamines et du potassium et sodium selon les résultats des analyses
- ⇒ **Son jeûne a duré 382 jours**
 - Il a brûlé 125 kg de graisses
 - Pèse 82 kg à la fin de son jeûne
 - Se stabilise à 89 kg dans les 5 années suivantes



Features of a successful therapeutic fast of 382 days' duration

W K Stewart, L W Fleming

PMID: 4803438 PMCID: PMC2495396 DOI: 10.1136/pgmj.49.569.203

Free PMC article

Un homme de 27 ans a jeûné sous surveillance pendant 382 jours et a ensuite maintenu son poids normal. Des concentrations de glucose sanguin d'environ 30 mg/100 ml ont été enregistrées de manière constante au cours des 8 derniers mois, bien que le patient ait été ambulatoire et soigné en ambulatoire. Les réponses aux tests de tolérance au glucose et au tolbutamide sont restées normales. La réponse hyperglycémique au glucagon a été réduite et finalement absente, mais est rapidement revenue à la normale pendant la réalimentation en glucides. Après correction d'une diminution initiale, les taux plasmatiques de potassium sont restés normaux sans supplémentation. Une période temporaire d'hypercalcémie s'est produite vers la fin du jeûne. La diminution des concentrations plasmatiques de magnésium était une caractéristique constante à partir du premier mois. Après 100 jours de jeûne, il y avait une augmentation marquée et persistante de l'excrétion des cations urinaires et du phosphate inorganique, qui jusque-là avait été minime. Ces augmentations peuvent être dues à la dissolution d'un excès de tissus mous et de masse squelettique. Le jeûne prolongé chez ce patient n'a eu aucun effet néfaste.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4803438/>

❖ Quid des patients obèses ?

• Indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30

- ⇒ Selon la nutrition.fr: environ 15% des adultes dans le monde
- ⇒ Avec des troubles des conduites alimentaires (TCA) ou non

• Parmi ceux qui perdent beaucoup de poids, au cours d'un jeûne, beaucoup en reprennent souvent et ce de façon importante après le jeûne

- ⇒ Les rapports de cas n'en parlent généralement pas par manque de suivi dans le temps

❖ Fin du jeûne

La réalimentation doit impérativement reprendre

- ⇒ Dès la sensation de faim impérieuse

➔ Le jeûne une nouvelle thérapie? (youtube.com)

III. LES EFFETS DU JEUNE SUR L'ORGANISME

1. ADAPTATION DU METABOLISME

❖ Le métabolisme s'adapte

Priver le corps de nourriture, c'est le priver de calories

⇒ Le métabolisme baisse à environ 1600-1700 calories / 24 heures

- **Une fois les sucres disponibles épuisés, le corps s'adapte**

⇒ En réduisant ses dépenses en énergie

- Impression de vivre au ralenti

⇒ En puisant dans l'organisme tout ce qui peut lui fournir de l'énergie

- dans les «réserves» que sont les graisses, les tissus musculaires...
- dans les dépôts de l'organisme: kystes, lipomes, dépôts de cholestérol,...

Alain Huot, Le Jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit

2. L'AUTOPHAGIE

❖ L'autophagie ou le recyclage cellulaire

- **Processus par lequel les cellules absorbent, détruisent ou recyclent leurs organelles intracellulaires dysfonctionnelles tout en préservant leur propre fonctionnement**

- Grec: auto (soi-même) et phagein (manger)

- **Le Dr Christian de Duve, médecin anglais, Prix Nobel de physiologie ou de médecine 1974**

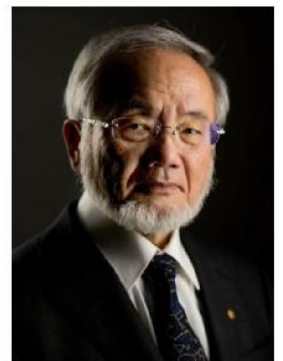
⇒ A observé et décrit que les cellules ont la capacité d'absorber, de détruire et de recycler certaines composantes endommagées ou dysfonctionnelles pour optimiser leur fonctionnement



L'autophagie ou le recyclage cellulaire

- **Yoshinori Ohsumi, biologiste japonais, Prix Nobel de physiologie ou de médecine 2016**

⇒ A découvert les protéines qui participent à la voie de signalisation de l'autophagie et comment ces protéines sont régulées



➤ **mTOR protéine kinase**

⇒ **Enzyme impliquée dans la régulation des protéines cibles**

⇒ Principal régulateur de la croissance et du renouvellement cellulaire

- Soit les cellules s'adaptent au manque de nutriment
- Soit les cellules croissent, se divisent et prolifèrent

- **En présence de glucose, acides aminés et insuline dans la circulation sanguine**

⇒ le corps se sait en état d'abondance: mTOR est activé

- **Au fur et à mesure que les taux de glucose, d'acides aminés et d'insuline baissent dans le sang**

⇒ La glycémie et plus basse que d'habitude, la cétonémie grimpe

⇒ **mTOR se désactive et l'autophagie s'amplifie**

L'effet du jeûne ou de la restriction calorique sur l'induction de l'autophagie: une revue de la littérature

Mohammad Bagherniya ¹, Alexandra E Butler ², Georges E Barreto ³, Amirhossein Sahebkar ⁴

Affiliations + développer

PMID: 30172870 DOI: 10.1016/j.arr.2018.08.004

L'autophagie est un processus de dégradation lysosomale et un mécanisme d'entretien ménager protecteur pour éliminer les organites endommagés, les protéines mal repliées à longue durée de vie et les agents pathogènes envahissants. L'autophagie fonctionne pour recycler les blocs de construction et l'énergie pour la rénovation cellulaire et l'homéostasie, permettant aux cellules de s'adapter au stress. La modulation de l'autophagie est une cible thérapeutique potentielle pour un large éventail de maladies, y compris les conditions métaboliques, les maladies neurodégénératives, les cancers et les maladies infectieuses. Traditionnellement, la privation alimentaire et la restriction calorique (RC) ont été considérées comme ralentissant le vieillissement et augmentant la longévité. Étant donné que l'inhibition de l'autophagie atténue les effets anti-âge de la RC, il a été proposé que l'autophagie joue un rôle important dans la longévité médiée par la RC. Parmi plusieurs inducteurs de stimuli de stress de l'autophagie, le jeûne et la RC sont les stimulateurs d'autophagie non génétiques les plus puissants et n'ont pas les effets secondaires indésirables associés aux interventions alternatives. Malgré l'importance de l'autophagie, les preuves reliant le jeûne ou la RC à la promotion de l'autophagie n'ont pas encore été examinées. Par conséquent, notre objectif était de peser les preuves relatives à l'effet de la RC ou du jeûne sur la promotion de l'autophagie. Nous concluons que le jeûne et la RC ont tous deux un rôle dans la régulation à la hausse de l'autophagie, les preuves suggérant de manière écrasante que l'autophagie est induite dans une grande variété de tissus et d'organes en réponse à la privation de nourriture.

Mots-clés: Autophagie; Restriction calorique; Jeûne.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30172870/>

3. LA CRISE D'ACIDOSE

⇒ **Le plus difficile n'est pas de se priver de nourriture, le passage délicat peut être la crise d'acidose.**

❖ La crise d'acidose

- Réaction de nettoyage, de désintoxication qui provoque une aggravation temporaire des symptômes
- La conversion des acides gras en corps cétoniques
- Majore l'acidose de l'organisme

⇒ Deux corps cétoniques ont une fonction acide

- Acide acétylacétique
- Acide B-hydroxybutyrique

⇒ L'acétone est éliminée par la voie pulmonaire et rénale

- **Peut engendrer des nausées**

➔ Alain Huot, *Le Jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit*

❖ **Les troubles liés à la crise d'acidose**

- **Hypothermie légère et passagère**

⇒ de 37,2° à 36,5° voire 36°

- moins de dépenses physiques

- activité thyroïdienne modérée

⇒ Il est préférable de jeuner en période d'été

- **Sur vigilance du système immunitaire**

⇒ L'immunité remonte mais elle peut s'affoler

- Certains jeûnes mal conduits peuvent réactiver une pathologie auto-immune

- **Excrétions intenses et chargées**

⇒ Tous les émonctoires sont extrêmement sollicités

- urines, sels, sueurs, crachats, etc.

➔ Alain Huot, *Le Jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit*

⇒ Une hypothermie

⇒ Des nausées, des vomissements,

⇒ Des diarrhées,

⇒ Des sueurs, de la fièvre,

⇒ Des tremblements,

⇒ Un état migraineux, des maux de tête,

⇒ Des malaises vagues,

⇒ De la tachycardie, baisse de tension, augmentation des pulsations,

⇒ Des douleurs stomacales,

⇒ Des douleurs articulaires,

⇒ De la goutte,

⇒ Des éruptions, cutanées

⇒ Une urine très foncée

⇒ Une chute de vitalité...

❖ Effets indésirables associés au jeûne hydrique

• Etude menée en Californie

- ⇒ Des médecins ont voulu connaître les effets indésirables d'un jeûne hydrique, et de la reprise de l'alimentation qui suit le jeûne.
- ⇒ **Analyse de 768 dossiers de visites de 652 patients** ayant participé, dans une clinique californienne à un jeûne médicalement supervisé (2006-2011)

Nbre de jeûnes	Durée du jeûne
446	2 à 7 jours
238	8 à 14 jours
64	14 à 21 jours
19	
1	41 jours

<https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-0182136-6>

• Les effets indésirables sont classés internationalement selon leur sévérité

Sévérité	Critères
Grade 1 (légère)	N'affecte pas l'activité quotidienne habituelle du patient. Signes ou symptômes ne nécessitant le plus souvent aucun traitement.
Grade 2 (modérée)	Perturbe l'activité quotidienne habituelle du patient. Nécessite, le plus souvent, un traitement médical ambulatoire sans interruption du traitement.
Grade 3 (sévère)	Empêche l'activité quotidienne habituelle du patient. Nécessite un traitement avec hospitalisation et/ou un arrêt du traitement supérieur ou égal à 4 jours.
Grade 4 (très sévère)	Menace le pronostic vital. Impose des mesures de réanimation.
Grade 5 (décès)	Complication mortelle.

Nbre de plaintes (%)	Sévérité des EI
555 (72%)	Grade 1 à 2
212 (28%)	Grade 3
1	Grade 4
0	Grade 5

=> Parmi les effets indésirables relevés dans les 768 dossiers médicaux,

Plaintes %	Nature plainte
48,2%	Fatigue
32,2 %	Nausées
33,5%	Insomnies
25,9%	Dyspepsie
25,7%	Douleurs dorsales

Les effets secondaires du jeûne les plus courants=>

Le jeûne est-il sans danger ? Un examen des dossiers des événements indésirables pendant le jeûne sous surveillance médicale et à l'eau seulement

John S. Finnell ,Bradley C. Saül ,Alan C. Goldhamer &Toshia R. Myers

BMC Médecine complémentaire et alternative 18 , Numéro d'article : 67 (2018) | Citer cet article

22 000 accès | 25 Citations | 124 Altmétrie | Métrique

Abstract

Arrière-plan

Les preuves suggèrent que le jeûne, pendant lequel seule de l'eau est consommée, entraîne des effets physiologiques potentiellement bénéfiques pour la santé. Cependant, les recherches évaluées par des pairs évaluant la sécurité du jeûne à l'eau seule font défaut. Pour résoudre ce problème, nous avons effectué un examen des dossiers pour décrire les événements indésirables (EI) survenus pendant le jeûne à l'eau seulement sous surveillance médicale.

Méthodes

Les dossiers électroniques des visites de patients dans un établissement médical résidentiel de 2006 à 2011 ont été examinés. Les patients âgés d'au moins 21 ans et à jeun uniquement hydrique pendant ≥ 2 jours consécutifs avec une période de réalimentation égale à la moitié de la durée du jeûne ont été inclus. Sur 2539 dossiers, 768 visites répondaient à nos critères d'inclusion et d'exclusion. Les EI ont été extraits des notes du dossier et classés selon la terminologie CTCAE (v4.03) et MedDRA (v12.1). Une analyse descriptive des EI est rapportée.

Résultats

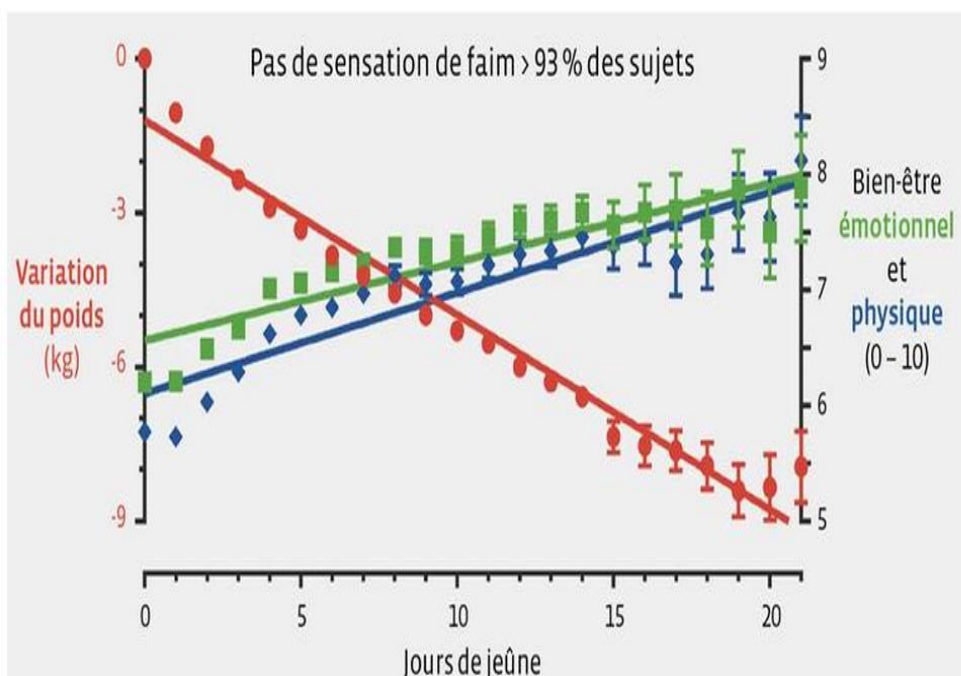
Au cours de la période du protocole, l'EI de grade le plus élevé (HGAE) sur 555 visites était un événement de grade 2 ou inférieur, sur 212 visites, il s'agissait d'un événement de grade 3, sur 1 visite, il s'agissait d'un événement de grade 4, et il n'y a eu aucun événement de grade 5. Il y a eu 2 (0,002 %) visites avec un événement indésirable grave (EIG). La majorité des EI identifiés étaient de nature légère (n = 4490, 75 %) et des réactions connues au jeûne.

conclusion

À notre connaissance, il s'agit de l'analyse la plus complète des EI subis lors d'un jeûne à l'eau seulement sous surveillance médicale menée à ce jour. Dans l'ensemble, nos données indiquent que la majorité des EI ressentis étaient des réactions légères à modérées et connues au jeûne. Cela suggère que le protocole utilisé dans cette étude peut être mis en œuvre en toute sécurité dans un cadre médical avec un risque minimal d'EIG.

<https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-018-2136-6>

❖ La sensation de faim durant le jeûne



Etude réalisée en 2016 par le centre Buchinger

- Sur les effets du jeûne long
- À partir d'un panel de 1422 personnes qui ont jeûné entre 4 et 21 jours

La plus grande étude jamais réalisée sur le jeûne, à la Clinique Buchinger Wilhelmi, sous la houlette de Wilhelmi de Toledo F, Grundler F, Michalsen A., en 2016, sur 1 422 adultes volontaires, sans abandon.

❖ Le jeûne Buchinger, une saga familiale

- Les centres Buchinger accueillent depuis 1878 des personnes pour le jeûne
- Méthode de jeûne Buchinger lancée par Otto Buchinger (1878-1966)
 - ⇒ Fonde avec sa fille Maria et son gendre Helmut Wilhelmi, une clinique à Überlingen, au bord du lac de Constance, qu'il dirige quelques années en qualité de médecin-chef, avant de s'éteindre à l'âge de 88 ans.
 - ⇒ Actuellement, les cliniques Buchinger sont administrées par le Dr Françoise Wilhelmi de Tolédo et ses deux fils
 - A entrepris depuis 10 ans de mener des études sur des panels de jeûneurs
 - On pourra lui reprocher d'être à la fois juge et partie
 - Néanmoins il existe peu d'études sur les effets des jeûnes thérapeutiques de longue durée



→ Dr Françoise Wilhelmi de Tolédo, L'art de jeûner, Eds Jouvence

❖ Étude réalisée en 2016 par le centre Buchinger sur les effets du jeûne long

Seules quelques études documentent des périodes de jeûne plus longues dans de grandes cohortes comprenant des participants non obèses. Le but de cette étude était de documenter de manière prospective la sécurité et tout changement des indicateurs de santé et de bien-être de base lors du jeûne périodique de Buchinger au sein d'une clinique spécialisée. Dans une étude observationnelle d'un an, 1422 sujets ont participé à un programme de jeûne consistant en des périodes de jeûne comprises entre 4 et 21 jours. Les sujets ont été regroupés en périodes de jeûne de 5, 10, 15 et 20 ± 2 jours. Les participants ont jeûné selon les directives de Buchinger avec un apport calorique quotidien de 200 à 250 kcal accompagné d'un programme de style de vie d'intensité modérée. Les paramètres cliniques ainsi que les effets indésirables et le bien-être ont été documentés quotidiennement. Des examens sanguins avant et à la fin de la période de jeûne ont complété l'analyse pré-post à l'aide de modèles linéaires à effets mixtes. Des réductions significatives du poids, de la circonférence abdominale et de la tension artérielle ont été observées dans l'ensemble du groupe (chacun $p < 0,001$). Un effet modulateur bénéfique du jeûne sur les lipides sanguins, la glucorégulation et d'autres paramètres sanguins généraux liés à la santé a été démontré. Dans tous les groupes, le jeûne a entraîné une diminution de la glycémie jusqu'à une plage normale basse et une augmentation des taux de corps cétoniques (chacun $p < 0,001$), documentant le changement métabolique. Une augmentation du bien-être physique et émotionnel (chacun $p < 0,001$) et une absence de sensation de faim chez 93,2 % des sujets ont soutenu la faisabilité d'un jeûne prolongé. Parmi les 404 sujets ayant des problèmes de santé préexistants, 341 (84,4 %) ont signalé une amélioration. Des effets indésirables ont été signalés chez moins de 1 % des participants. Les résultats de 1422 sujets ont montré pour la première fois que le jeûne périodique Buchinger d'une durée de 4 à 21 jours est sûr et bien toléré. Cela a conduit à une amélioration du bien-être émotionnel et physique et à des améliorations des facteurs de risque cardiovasculaires et généraux pertinents, ainsi que des problèmes de santé subjectifs.

Sécurité, amélioration de la santé et bien-être pendant une période de jeûne de 4 à 21 jours dans une étude observationnelle incluant 1422 sujets

Françoise Wilhelmi de Tolédo¹, Franziska Grundler^{1,2}, Audrey Bergouignan^{3,4,5,6}, Stefan Drinda¹, Andreas Michalsen^{7,8}

Affiliations + étendre

PMID : 30601864 PMID : PMC6314618 DOI : 10.1371/journal.pone.0209353

Article PMC gratuit

- Panel de 1422 personnes qui ont jeûné en 4 et 21 jours
- Selon les directives Buchinger (250 kcal/j)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30601864/>

IV. LES BENEFICES DU JEUNE

❖ Jeûne et santé du cerveau



Le cerveau utilise plus de 20% des apports caloriques pour son fonctionnement

Rester alerte face à son environnement, apprendre, réfléchir, restituer,...



Selon les travaux de l'équipe de Stephen Cunnane de l'université de Sherbrooke

Les cellules gluco-dépendantes préféreraient utiliser les corps cétoniques lorsqu'elles ont le choix



Le jeûne a un effet neuroprotecteur

Il harmonise les neuromédiateurs



Le jeûne aurait un effet positif

Problèmes neurologiques (migraines, neuropathies, vertiges)
Troubles psychiatriques (dépression, [anxiété](#), concentration)
Pathologies neuro-dégénératives

Journal of Cellular and Molecular Medicine

Open Access

[J Cell Mol Med.](#) 2018 mai ; 22(5): 2528–2535.

PMCID : PMC5908110

Publié en ligne le 21 février 2018. doi: [10.1111/jcmm.13418](#)

PMID : [29465826](#)

Effet de la restriction calorique sur la dépression

[Stephen Malunga Manchishi](#) , ^{1, 2} [Ran Ji Cui](#) , ¹ [Xiao Han Zou](#) , ¹ [Zi Qian Cheng](#) , ¹ et [Bing jin Li](#) ^{1✉✉}

► Informations sur l'auteur Notes sur l'article ► Informations sur le ► copyright et la licence [Avis de non-responsabilité](#)

Cet article a été [cité par d'](#) autres articles dans PMC.

Abstrait

[Aller à: ►](#)

Récemment, la plupart des preuves montrent que la restriction calorique pourrait induire des effets de type antidépresseur dans un modèle animal de dépression. D'après des études sur l'axe cerveau-intestin, certaines voies de signalisation étaient communes entre le contrôle de la restriction calorique et la dépression. Cependant, le mécanisme spécifique des effets de type antidépresseur induits par la restriction calorique reste incertain. Par conséquent, dans cet article, nous avons résumé les études cliniques et expérimentales de la restriction calorique sur la dépression. Cette revue pourrait fournir une nouvelle stratégie thérapeutique pour la dépression.

Mots clés : antidépresseur, jeûne, restriction calorique, BDNF

<https://www.ncbi.>

Le jeûne périodique volontaire à des fins religieuses ou culturelles ou involontairement par manque est une pratique courante dans le monde. Le jeûne médical ou thérapeutique est également pratiqué et s'est avéré sûr [13](#). Le jeûne augmente de manière aiguë les niveaux de l'hormone gastro-intestinale orexigène, l'acyl-ghréline. La gréline est un ligand du récepteur sécrétagogue de l'hormone de croissance (Ghr) dans l'hippocampe, augmentant les niveaux du gyrus denté du facteur de transcription neurogène Egr-1, améliorant la neurogenèse hippocampique adulte [26](#).

Nous avons précédemment montré que le jeûne aigu produisait des effets de type antidépresseur chez la souris, accompagnés d'une augmentation des catécholamines et des glucocorticoïdes [42](#). Pour se protéger des effets potentiellement délétères de ces hormones, les mécanismes cellulaires du cerveau de résistance au stress qui pourraient favoriser la neurogenèse, la synthèse de facteurs neurotrophiques, les récepteurs des neurotransmetteurs et les protéines chaperonnes sont activés [13](#). Le jeûne à court terme conduit à une régulation à la hausse spectaculaire de l'autophagie neuronale (parfois appelée nettoyage cellulaire) caractérisée par une diminution de l'activité neuronale mTOR *in vivo* [25](#). Des études sur des modèles de rongeurs ont montré que le jeûne améliorait la disponibilité du tryptophane et de la sérotonine dans le cerveau [46](#). 5 à 10 jours de jeûne chez l'homme ou 1 à 2 jours chez le rat induiraient des libérations d'endorphines endogènes, ce qui pourrait expliquer les améliorations de l'humeur sans corrélation avec la perte de poids [13](#). D'autres études ont montré que le jeûne intermittent provoque une augmentation du BDNF, qui est l'un des facteurs neurotrophiques connus impliqués dans de nombreux antidépresseurs (tableau [1](#))

Étude réalisée en 2016 par le centre Buchinger sur les effets du jeûne long

L'augmentation continue du bien-être émotionnel et physique était évidente dans tous les groupes de différentes durées de période de jeûne. Ceci est un élément important pour augmenter l'observance et a été rapporté dans des études antérieures basées sur des évaluations d'humeur quotidiennes [26](#), [52](#), [53](#). La perte de poids, en particulier chez les sujets obèses, est liée à l'amélioration de l'humeur dans de nombreuses études [54](#). Il a été démontré que le commutateur G-to-K dans IF conduit à une amélioration des performances dans les fonctions cognitives, de l'humeur, motrices et du système nerveux autonome [2](#), [55](#). En IF et CR ceci est lié à la libération de BDNF [51](#), [56](#). Le BDNF, associé à la neurogenèse et à la protection des neurones, améliore la croissance et la survie des neurones à sérotonine [51](#), [57](#). De plus, la réduction des taux d'insuline et de leptine semble agir sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, impactant ainsi positivement l'humeur [58](#). Les opioïdes endogènes (β -endorphines) pourraient également contribuer au bien-être, comme le montre un essai de jeûne de 10 jours chez les hommes [59](#).

Dans notre étude, l'amélioration rapportée d'un problème de santé majeur, souvent accompagnée d'un soulagement de la douleur, pourrait éventuellement contribuer à l'augmentation du bien-être. De plus, il semble probable que la réussite d'une période de jeûne plus longue améliore le sentiment d'auto-efficacité, améliorant ainsi le bien-être subjectif [37](#). Il a été rapporté que de courtes périodes de jeûne de deux jours, ainsi que le jeûne d'un jour sur deux, sont associés à la sensation de faim [60](#) - [62](#). Cela semble être un obstacle à l'observance du patient [61](#), [62](#). En revanche, la faim n'a pas été rapportée par 93% des sujets de notre étude, ce qui les a souvent surpris positivement. Cela a peut-être contribué à améliorer le bien-être.

Sécurité, amélioration de la santé et bien-être pendant une période de jeûne de 4 à 21 jours dans une étude observationnelle incluant 1422 sujets

Françoise Wilhelmi de Tolède ¹, Franziska Grundler ^{1, 2}, Audrey Bergouignan ^{3, 4, 5, 6}, Stefan Drinda ¹, Andreas Michalsen ^{7, 8}

Affiliations + étendre

PMID : 30601864 PMCID : PMC6314618 DOI : 10.1371/journal.pone.0209353

Article PMC gratuit

- Augmentation du bien-être physique et émotionnel

❖ Jeûne et métabolisme

- **Le jeûne peut être un outil thérapeutique pour**

- ⇒ Perdre de la masse grasseuse
- ⇒ Mieux contrôler l'appétit
- ⇒ Normaliser la glycémie
- ⇒ Améliorer la sensibilité à l'insuline
- ⇒ Normaliser des taux de cholestérol et des triglycérides
- ⇒ Diminuer la pression artérielle

- **Selon le Dr Bourdua-Roy, le jeûne est un outil thérapeutique pour contrer le surpoids et l'obésité**

Objet de l'examen : Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont l'une des principales causes de décès dans le monde. La nutrition joue un rôle central dans le risque de MCV en affectant le vieillissement, l'adiposité, la glycémie, la pression artérielle, le cholestérol, l'inflammation et d'autres facteurs de risque et peut affecter le risque de MCV non seulement en fonction de l'apport calorique et de la composition alimentaire, mais également du moment et de la gamme des repas. Cette revue évalue les effets du jeûne, des régimes imitant le jeûne et de l'alimentation à durée limitée sur la réduction des facteurs de risque de MCV et fournit des données initiales sur leur potentiel à servir de thérapies de prévention et de traitement des MCV.

Découvertes récentes : Le jeûne intermittent (IF), l'alimentation limitée dans le temps (TRE), le jeûne prolongé (PF) et les régimes imitant le jeûne (FMD) sont prometteurs dans la réduction des facteurs de risque de MCV. Les résultats sur l'IF, le TRE, le PF et la fièvre aphteuse sur les facteurs de risque de MCV sont significatifs et souvent indépendants de la perte de poids, mais des études à long terme sur leur effet sur les MCV font encore défaut. Le couplage de cycles périodiques et prolongés, ou intermittents et plus fréquents de régimes à jeun ou imitant le jeûne, conçus pour maximiser l'observance et minimiser les effets secondaires, a le potentiel de jouer un rôle central dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires et du syndrome métabolique.

Mots clés : Maladie cardiométabolique ; Régime imitant le jeûne ; Jeûne intermittent; Obésité; Temps limité pour manger.



La revue > Curr Diab Representant.10 décembre 2020;20(12):83.
doi : 10.1007/s11892-020-01362-4.

Jeûne périodique et intermittent dans le diabète et les maladies cardiovasculaires

Annunziata Nancy Crupi ¹, Jonathan Hase ¹, Sébastien Brandhorst ¹, Valter D Longo ^{2, 3}

Affiliations + étendre

PMID : 33301104 DOI : 10.1007/s11892-020-01362-4

- **Selon le Dr Bourdua-Roy, le jeûne pourrait être efficace pour inverser la stéatose hépatique ➤?Si elle n'a pas atteint le stade de la cirrhose**

- ⇒ Les jeûnes doivent être prolongés et répétés
- ⇒ L'alimentation entre les jeûnes doit permettre de minimiser la sécrétion d'insuline
- ⇒ Une étude a montré qu'un jeûne de 64 heures (2 jours et demi) avait permis aux participants de réduire le volume de leur foie de 23% en moyenne

Quantitation of hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis in fasting humans with ^{13}C NMR

D L Rothman¹, I Magnusson, L D Katz, R G Shulman, G I Shulman

Affiliations + expand

PMID: 1948033 DOI: 10.1126/science.1948033

Le taux de glycogénolyse hépatique nette a été évalué chez l'homme en mesurant en série la concentration de glycogène hépatique à des intervalles de 3 à 12 heures au cours d'un jeûne de 68 heures avec spectroscopie par résonance magnétique nucléaire ^{13}C . Le taux net de gluconéogenèse a été calculé en soustrayant le taux de glycogénolyse hépatique nette du taux de production de glucose dans tout le corps mesuré avec du glucose tritié. La gluconéogenèse représentait $64 \pm 5\%$ (erreur type moyenne $\pm$ de la moyenne) de la production totale de glucose au cours des 22 premières heures de jeûne. Au cours des périodes suivantes de 14 heures et 18 heures du jeûne, la gluconéogenèse représentait respectivement $82 \pm 5\%$ et $96 \pm 1\%$ de la production totale de glucose. Ces données montrent que la gluconéogenèse représente une fraction substantielle de la production totale de glucose, même pendant les 22 premières heures d'un jeûne chez l'homme.

❖ Jeûne et cancer

- **Valter Longo, directeur du Laboratoire Longévité et Cancer de l'IFOM, Institut Firc d'Oncologie Moléculaire de Milan**

- **Dirige l'Institut de la longévité de l'université de Californie du Sud** (Los Angeles), où il est également professeur de gériatrie (étude des phénomènes de vieillissement et des problèmes liés aux personnes âgées) et de biologie



- **Résultats d'une étude expérimentale**

- ⇒ montre qu'un traitement métabolique du cancer mimant le jeûne stimule l'immunité et amplifie les bénéfices de la chimiothérapie
- ⇒ L'autophagie permet d'optimiser les réparations cellulaires
- ⇒ La modification de l'expression des gènes permet des 48h de jeûne aux cellules saines
 - De mieux se protéger contre l'effet du vieillissement
 - et mieux supporter des traitements chimio-thérapeutiques
- ⇒ Le renouvellement cellulaire accéléré dès 72h de jeûne

➔ **Pr Valter Longo, Le régime de longévité, Eds Actes Sud**

Jeûne et cancer : mécanismes moléculaires et application clinique

Alessio Nencioni ^{1 2}, Irène Caffa ¹, Salvatore Cortellino ³, Valter D Longo ^{4 5}

Affiliations + étendre

PMID : 30327499 PMCID : PMC6938162 DOI : 10.1038/s41568-018-0061-0

Article PMC gratuit

La vulnérabilité des cellules cancéreuses à la privation de nutriments et leur dépendance à des métabolites spécifiques sont des caractéristiques émergentes du cancer. Les régimes à jeun ou imitant le jeûne (FMD) entraînent de larges altérations des facteurs de croissance et des niveaux de métabolites, générant des environnements qui peuvent réduire la capacité des cellules cancéreuses à s'adapter et à survivre et ainsi améliorer les effets des thérapies anticancéreuses. De plus, le jeûne ou la fièvre aphteuse augmentent la résistance à la chimiothérapie dans les cellules normales mais pas cancéreuses et favorisent la régénération des tissus normaux, ce qui pourrait aider à prévenir les effets secondaires néfastes et potentiellement mortels des traitements. Bien que le jeûne soit difficilement toléré par les patients, les études animales et cliniques montrent que les cycles de fièvre aphteuse hypocalorique sont réalisables et globalement sûrs. Plusieurs essais cliniques évaluant l'effet du jeûne ou de la fièvre aphteuse sur les événements indésirables liés au traitement et sur les résultats d'efficacité sont en cours. Nous proposons que la combinaison des FMD avec la chimiothérapie, l'immunothérapie ou d'autres traitements représente une stratégie potentiellement prometteuse pour augmenter l'efficacité du traitement, prévenir l'acquisition de résistance et réduire les effets secondaires.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30327499/>

V. CONTRE INDICATION AU JEUNE

⇒ **Le jeûne nécessite une pleine adhésion du pratiquant**

❖ Contre-indications absolues

• Grossesse et allaitement

• Enfants de moins de 18a

• Malades épuisés, dévitalisés,

- ⇒ Grande faiblesse avec insuffisance émonctorielle
- ⇒ Maigreurs extrêmes et cachexie
- ⇒ Malades sous médicaments chimiques lourdes

• Troubles alimentaires

- ⇒ Anorexie

• Troubles lésionnels

- ⇒ Ulcères touchant le système digestif
- ⇒ Hyperthyroïdie non régulée
- ⇒ Cancers en phase active

Dr Evelyne Bourdua-Roy et Sophie Rolland, Comment jeûner

- **Insuffisances sévères**
 - ⇒ Insuffisance hépatique sévère
 - ⇒ Insuffisance rénale sévère: hémodialyse, néphropathie
 - ⇒ Insuffisance respiratoire sévère: BPCO, emphysème
 - ⇒ Insuffisance cardiaque sévère
 - ⇒ Diabète insulino-dépendant, type 1

- **Troubles mentaux**

- ⇒ Schizophrénie
- ⇒ Psychose
- ⇒ Phobie du jeûne

❖ Contre-indications relatives

- Personnes fragiles ou frêles
- Maigreur installée
- Hypotension artérielle
- Diabète traité avec de l'insuline et mal contrôlé
- Boulimie
- Troubles cognitifs
- Chirurgie récente

➔ **Le Dr Bourdua-Roy recommande d'en parler avec un professionnel de santé qui s'y connaît bien en jeûne**

VI. LA PRATIQUE DU JEUNE

1. SE PREPARER A JEUNER

- ⇒ Une personne qui se lance dans un marathon sans préparation se montre peu respectueuse de son propre corps. Il en est de même pour le jeûne.

❖ Pourquoi jeûner ?

- **Acte murement réfléchi**
- **Se fixer des objectifs donne un cap**
- **Motivation à jeûner**
 - ⇒ Raisons médicales
 - ⇒ Apprendre à mieux gérer mon poids
 - ⇒ C'est mon corps qui me le réclame, je me sens encrassé
 - ⇒ Besoin de faire une pause, de prendre de la distance
 - ⇒ Envie de rester le plus longtemps possible en bonne santé

➔ **Alain Huot, Le Jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit**

2. LA DESCENTE ALIMENTAIRE

- **Réduction progressive des aliments sur 7 jours**

⇒ Durée de la descente égale à la durée de la cure

- **Orientée vers des aliments riches en fibres**

- ⇒ Haut pouvoir satiétogène
- ⇒ Réduire notre ration alimentaire
- ⇒ Apporter moins d'énergie au corps
- ⇒ Diminuer la sécrétion d'insuline

- **Il est important de manger à satiété**

⇒ Ne pas rester affamé

- **Et de bien s'hydrater**

⇒ **1,5 à 2L par jour**

Alain Huot, Le Jeûne, une voie royale pour la santé du corps et de l'esprit

J-7: On élimine les aliments encrassants

- Les aliments industriels
- Les excitants: alcool, café, thé, cigarette
- Le sucre
- Les produits animaux: viandes, lait, fromages
- Les céréales raffinées: pain blanc, riz blanc, pâtes

J-4: On élimine les céréales à gluten

- Les céréales à gluten: seigle, avoine, blé, orge
- Les produits animaux: poissons, œufs

J-2: On élimine toutes les céréales

- Les céréales sans gluten: riz, millet, quinoa, sarrasin
- Les féculents: légumineuses, patate douce, pomme de terre

A J-2 on ne mange que

- Des légumes crus et cuits, des fruits crus, puis cuits
- Des graines et oléagineux
- Des graines germées

Le jour J

- Des légumes verts bien cuits et fibreux
 - Poireaux, épinards, blettes, courgettes
- Eventuellement des pommes cuites

3. L'ENTREE DANS LE JEUNE : LA PURGE

❖ La purge

- **Entrée dans le jeûne proprement dite**

- ⇒ 5 à 6h après la dernière collation
- ⇒ Libérer les intestins des restes alimentaires des repas précédents

- **Pratique Ayurvédique Shankaparakhalana**

- ⇒ Pratique de nettoyage des intestins avec de l'eau fortement salée
 - Déclenche une diarrhée



- **Sulfate de magnésium (ou chlorumagene)**

- ⇒ Selon Andreas Moritz dans son protocole de nettoyage du foie et de la VB
- ⇒ Sel laxatif
- ⇒ Élargit les conduits hépatobiliaires
 - Facilite l'élimination des boues et des calculs biliaires
- ⇒ 15 à 30 g dans un verre d'eau
- ⇒ La dose dépend du transit
 - Dose maximale pour un transit lent

4. OPTIMISER SON JEUNE

❖ Les lavements

- **Un lavement quotidien**

- ⇒ Éviter que les toxines et déchets libérés par le jeûne soient réabsorbés au niveau intestinal
- ⇒ Ramollir les vieilles matières concentrées et collées sur la paroi du côlon pour ensuite les éliminer
- ⇒ Le péristaltisme intestinal est réactivé par l'introduction de 1 litre d'eau tiède dans le rectum



❖ Le psyllium

Issu d'une plante vivace **Plantago ovata**, **Plantain des indes** ou **Ispaghul**

- ⇒ Crée une forme de gel mucilage
- ⇒ Lubrifie le tractus digestif
- ⇒ Action de balayage de l'œsophage jusqu'au rectum
- ⇒ 1 cuillère à soupe rase dans ¼ litre d'eau



❖ La phytologie

Plantes en soutien du foie

- Romarin
- Pissenlit
- HECT citron
- Menthe poivrée



Plantes en soutien des reins

- Boldo
- Hibiscus
- Orthosiphon
- Piloselle
- Reine des près



❖ Activité physique

Pratiquer une activité physique quotidienne

➤ Marche d'oxygénation en pleine nature

- Augmente les échanges au niveau des organes d'élimination
- Pratique un automassage des viscères par la sollicitation des muscles abdominaux
- Sollicite les articulations en douceur
- Élimine les acides volatiles dont font partie certains corps cétoniques
- Augmente le rythme cardiovasculaire,
- Intensifie la filtration rénale et l'épuration hépatique
- Permet de se ressourcer dans la nature

➤ Rester statique

- gêne l'élimination des déchets et toxines remis en circulation
- avec le risque qu'ils restent bloqués dans les voies de rétrécissement: articulations Après une marche d'oxygénation, la vitalité doit être améliorée

Pratiquer une gymnastique douce: yoga

Libère les toxines bloquées dans les articulations et les tissus

- Stimule les grandes chaînes tendino-musculaires
- Postures de torsion favorisent un essorage des organes internes
- Postures axées sur les étirements permettent de travailler notamment sur le psoas



❖ Temps pour soi

Massages

Réflexologie

Balnéothérapie, sauna, hammam

Soins énergétiques

VII. L'ENTREE DANS LE JEUNE : LA PURGE

1. La reprise alimentaire

La durée de la reprise correspond à la durée du jeûne

- Pour un jeûne de 6 jours, il faut prévoir 6 jours de reprise

Doit être progressive et respectueuse de notre corps

La reprise alimentaire

- Informe le système digestif
- Relance la mastication
- Relance les sécrétions digestives
 - Graines de lins trempées, graines de chia trempées, pruneaux trempés

❖ Repas de rupture du jeûne

Aliments simples à digérer et en petite quantité

- Des légumes cuits: Apport de fibres qui servent de substrat au microbiote intestinal
 - courgette, poireau, courge, épinards, blettes
- Des légumes crus: Apport d'enzymes qui relancent la digestion
 - jus de légumes fraîchement pressés et bien dilués,
 - soupe crue,
 - crudités douces
 - aromates,
 - graines germées



J1-J2

- Des légumes cuits: Servis en petite quantité dans une coupelle à dessert avec une cuillère à café
 - Courgette, épinard, feuille de blettes, chou kale, brocolis, courge, patate douce
- Des légumes crus
 - Jus de légumes fraîchement pressés,
 - Soupe crue, Crudités douces, Graines germées
- Des oléagineux
- Des algues, herbes, aromates
- Des fruits cuits à distance des légumes



J3

- Des légumes cuits
- Des légumes crus
- Des légumes lacto-fermentés
- Des oléagineux: noix, noix de cajou, amandes, avocat
- Des algues, herbes, aromates, graines germées
- Des fruits cuits à distance des légumes
- Huile olive et vinaigre de cidre ou citron



J4

- Des protéines végétales : légumineuses à faire tremper la veille
- Des céréales ou pain sans gluten: quinoa, sarrasin



J5-J6

- Les sous-produits animaux: œufs, fromages frais: chèvre, brebis



J7

- Les protéines animales: volailles, poisson
- Les céréales à gluten: seigle, avoine, blé, orge



A chacun son rythme... à l'écoute de son corps et de son foie !

❖ Les superaliments

Aliments 100 % naturels ayant une forte valeur nutritionnelle

- Riches en divers nutriments, antioxydants, minéraux, vitamines, oligo-éléments, protéines, acides gras, et composés actifs

Graines

- Graines germées, Graines de chia, de chanvre, de courge

Superfruits

- Baies rouges, baies de goji, baies d'aronia, mulberry, physalis, cranberry, grenade, fève de cacao
- Attention à l'IG des fruits secs

Spiruline



Algues marines



Pollen



Eau de quinton / plasma marin



❖ La reprise alimentaire

• Peut aussi être un risque de boulimie passagère

- ⇒ Réveil de l'inconscient
 - Fait passer des envies
- ⇒ Phénomène passager
- ⇒ Mettre un peu de mental pour ne pas céder à cette tentation qui ne va pas durer

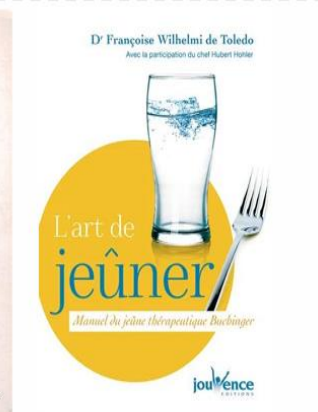
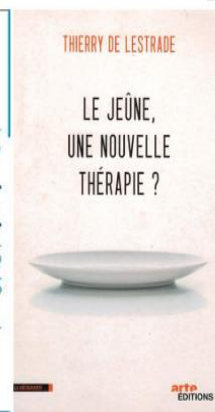
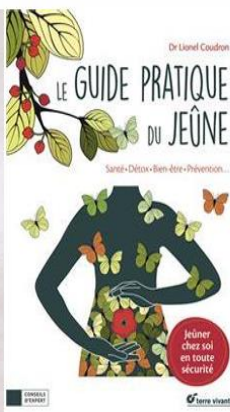
2. ET APRES LE JEUNE

❖ Continuer à profiter des bienfaits du jeûne

Adopter des temps de repos digestifs: 4-2-1

- 4 jours où je mange une alimentation saine et vivante
- 2 jours où je me fais plaisir
- 1 jour où je régule
- en instaurant une monodiète, un jeûne intermittent, ...

❖ Bibliographie



Le jeûne, Enquête
sur un phénomène
Sylvie Gilman,
Thierry De Lestrade



Le jeûne, Une
nouvelle thérapie
Sylvie Gilman,
Thierry De Lestrade

❖ Académie médicale du jeûne

- Association créée par des médecins qui ont une pratique régulière du jeûne
- Diffuser une information méconnue sur la pratique du jeûne et son intérêt thérapeutique.
- Faire reconnaître et promouvoir l'utilisation du jeûne comme moyen thérapeutique
- Constituer un réseau de médecins référents pour la surveillance et l'accompagnement médical du jeûne
- Établir et diffuser une veille documentaire sur les études scientifiques ou cliniques concernant le jeûne et la nutrition.



<https://academie-medicale-du-jeune.fr/>

